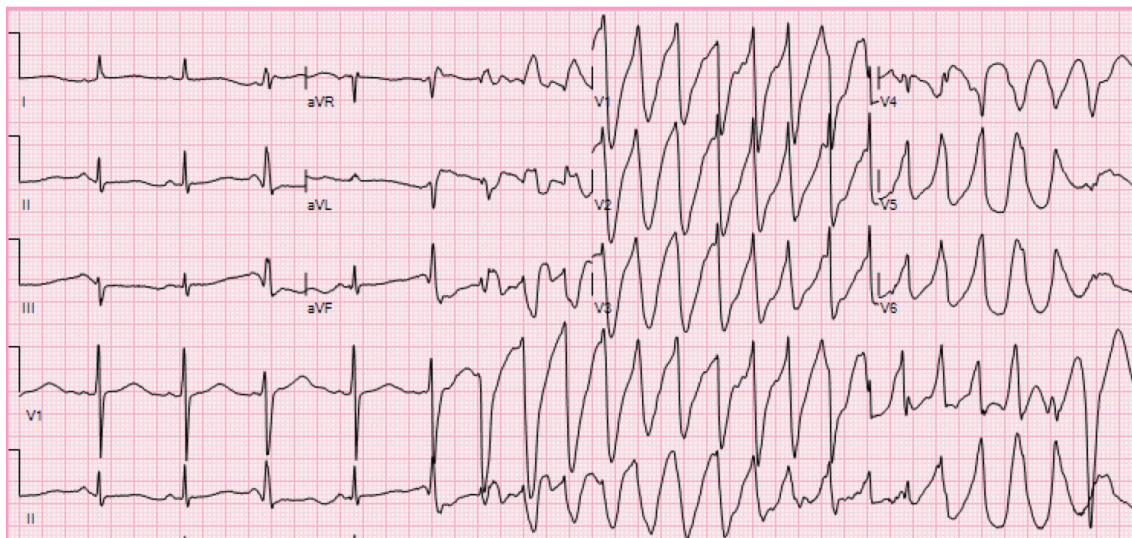


Πολύμορφη Κοιλιακή Ταχυκαρδία – Torsade de Pointes (TdP)

- Η άτυπη αυτή (ριπιδιοειδής) κοιλιακή ταχυκαρδία συμβαίνει όταν ο άξονας των QRS, σε μία ΗΚΓφική απαγωγή, παλινδρομεί από θετική σε αρνητική κατεύθυνση. Η κοιλιακή συχνότητα είναι αρκετά μεγάλη και ανέρχεται σε 150-200 σφύξεις/λεπτό (bpm).
- Η εμφάνιση της TdP συχνά συνδέεται με παράταση του διαστήματος QT ή με συγγενή σύνδρομο μακρού QT (π.χ. σύνδρομο Romano-Ward, σύνδρομο Jervell-Lange-Nielsen).



- Ποικίλα φάρμακα, ηλεκτρολυτικές διαταραχές και νόσοι προδιαθέτουν για την εμφάνιση της αρρυθμίας. Στα προδιαθεσικά φάρμακα για την εμφάνιση TdP, περιλαμβάνονται τα αντιαρρυθμικά (προκαϊναμίδη, κινιδίνη, αμιωδαρόνη), φάρμακα κατά των λοιμώξεων (ερυθρομυκίνη, φθοριοκινολόνες, πενταμιδίνη, κετοконаζόλη), τα ψυχοτρόπα φάρμακα (λίθιο, αλοπεριδόλη, φαινοθειαζίνες, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά), οι βλάβες του ΚΝΣ, τραύμα, ισχαιμία μυοκαρδίου, υποθερμία, βαριά υπογλυκαιμία, ασιτία. Προδιαθεσικές ηλεκτρολυτικές διαταραχές θεωρούνται οι ένδειες ασβεστίου, καλίου και μαγνησίου.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Η αντιμετώπιση της TdP εξαρτάται από το διάστημα QT. Όταν το διάστημα QT είναι παρατεταμένο, η αρρυθμία είναι ανθεκτική στα παραδοσιακά αντιαρρυθμικά φάρμακα. Η άμεση διακομίδη του ασθενούς στο νοσοκομείο είναι η βασική προτεραιότητά μας, διότι ο ασθενής μπορεί να χρειασθεί βηματοδότηση υπερκέρρασης (*overdrive pacing*).
2. Διακοπή των φαρμάκων και αντιμετώπιση των καταστάσεων που παρατείνουν το QT.
3. Τοποθετούμε ευρεία 3way φλεβική γραμμή και χορηγούμε οξυγόνο (6-10 lt/min O₂ με στόχο SpO₂ > 90%), ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να ανατάξουμε τα πιθανά αντιστρεπτά αίτια της αρρυθμίας (π.χ.: ηλεκτρολυτικές διαταραχές, υποθερμία).
4. Μπορούμε να χορηγήσουμε 1-2 gr **θεικό Μαγνήσιο** (δηλαδή ½ amp. ή 1 amp. MgSO₄) σε έγχυση 2-5 λεπτών (δηλαδή: 1-2 gr MgSO₄ μαζί με 50 ml N/S, σε iv-bolus έγχυση).
5. Εν συνεχεία, τοποθετούμε ορό 500 ml N/S, με 6 gr Μαγνησίου (ήτοι 3 amp. MgSO₄) και χορηγούμε το διάλυμα αυτό σε έγχυση διάρκειας 6 ωρών (ρυθμός χορήγησης: 1 gr/h).
6. Αφού ολοκληρωθεί η 1^η έγχυση του MgSO₄, χορηγούμε Κάλιο (δηλαδή: 1-2 amp. KCl εντός 250 ml NaCl 0,9% ή D₅W, σε διάστημα 1 ώρας). Τα επίπεδα K⁺ στον ορό πρέπει να διατηρούνται στα ανώτερα επιτρεπτά όρια, άνω των 4 mEq/L, για διατήρηση της σταθερότητας και της ομαλής λειτουργίας των κυτταρικών μεμβρανών του μυοκαρδίου.
7. Ασθενείς αιμοδυναμικά ασταθείς, με μείζονα κλινικά σημεία και συμπτώματα ιστικής υποάρδευσης χρειάζονται άμεση ηλεκτρική καρδιοανάταξη (ξεκινώντας με 50 Joules). Σε άσφυγη TdP χορηγείται απινίδωση (200 Joules) κι εφαρμόζουμε πρωτόκολλο ALS.